

- 喫煙常習者の IPF 発症オッズ比は 1.6~2.9 である。
- 肺線維症の発症に影響するとの報告もある。
- 様々な環境曝露により発症リスクが上昇する。
- 高血糖や糖尿病は発症リスクを高めるとされている。
- ✕ HLA との明らかな関連は報告されておらず、SP-C 遺伝子異常との関連が注目されている。

5

- 
- ✕ HRCT 所見で典型的な UIP パターンを示す場合には、外科的肺生検 (SLB) は必須ではない。
- 臨床的には主に clinical context of IPF を満たす症例で IPF が診断される。
- 
- 診断のゴールドスタンダードとされている。
- ✕ 診断や予後の推定に有効であるとはされていないが、他疾患の除外には有効な場合がある。
- 
- 非特異性間質性肺炎 (NSIP) や特発性器質化肺炎 (cryptogenic organizing pneumonia: COP) ではリンパ球比率は上昇する。